UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Anesthésie
Consultation pré anesthésique
avec patient
sans geste clinique

Nom du rédacteur : MADONNA Theo **Date de rédaction : 24/11/23**

Relecture intra-ou transdisciplinaire :

Situation de départ N° (300) – Consultation pré anesthésique

Domaine de compétence n°1 (en sélectionner 1 SEUL) : Entretien/interrogatoire

Attendus d'apprentissage de la situation abordée (cf. LISA : Catégorie:Situation de départ NG — LiSA (uness.fr)**):**

1-

2-

Patient simulé nécessaire à la station : OUI

Matériel nécessaire à la station

- Mannequin NON
- Brancard NON
- (Préciser tout matériel nécessaire, y compris poubelle DASRI, stéthoscope, etc.)

Exemple d'instructions au patient simulé

Rappel : seules les réponses précisées ci-dessous et les instructions peuvent être verbalisées. Le patient simulé ne doit rien dire d'autres que ce qui est précisé.

Synopsis :

Vous êtes Mme Martin 62 ans et vous êtes secrétaire. Vous avez un syndrome du canal carpien droit lié à votre travail extensif sur ordinateur, un chirurgien orthopédique a prévu de vous opérer dans 2 semaines pour soulager les douleurs. Afin de préparer l'opération, le chirurgien vous a prévu une consultation ce jour avec un médecin anesthésiste pour faire une consultation pré anesthésique.
Un étudiant en médecine va vous interroger.

Identité/Contexte (éléments indispensables)	Nom : Martin / Prénom : Laurence Age : 62 Secrétaire Mariée, 1 fils Vie à la maison avec son mari
Antécédents	Aucun en dehors du syndrome du canal carpien actuel qui persiste depuis maintenant 6 mois malgré plusieurs tentatives de prise en charge
Médicaments actuels/ Toxiques	*Aucun traitement* *Fume 10 cigarettes par jour depuis l'age de 17 ans*
Etats d'esprit/ comportement	Posture assise Douleur : faible au repos Angoisse : faible Colère : aucune
Déroulement du scénario	Vous êtes assise Lorsque l'étudiant vous demande pourquoi vous venez, commencez par : *Ex : "**Le chirurgien m'a prévu cette consultation par rapport à mon opération du canal carpien."*** Puis répondez aux questions de l'étudiant (cf tableau ci-dessous) et ne dévoilez les informations que s'il vous les demande spécifiquement. (Si l'étudiant ne parle pas du jeun, demander une minute avant la fin « Est-ce qu'il va falloir être à jeun ? », si l'étudiant parle du jeun sans préciser la durée, demander une minute avant la fin « Pendant

	combien de temps avant l'opération est-ce qu'il faudra être à jeun ? »
Autres questions à poser au médecin, à quel moment	

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Vous ne répondrez aux questions suivantes que si l'évalué (étudiant-médecin) vous les pose. Si les questions de l'étudiant-médecin ne sont pas listées ci-dessous, répondre « je ne sais pas ».

Questions éventuellement posées par l'étudiant - médecin	**Réponses à donner par le patient simulé**
Utiliser un vocabulaire simple sans jargon médical *Si les questions sont compliquées le patient doit dire : « Comment ? Je ne comprends pas la question. »*	
Avez-vous des maladies pour lesquelles vous etes suivie ?	Non
Prenez-vous des médicaments ?	Non
Avez-vous des allergies ?	Non
Est-ce que vous buvez / fumez / prenez des drogues ?	10 cigarettes/jour depuis 45 ans au total, pas d'alcool, pas de drogues
Avez-vous des troubles de la coagulation connus (médicaments ou maladies)	Non
Avez-vous actuellement des douleurs ?	C'est tolérable
Quels symptômes avez-vous actuellement ?	Des douleurs et des fourmillements dans les doigts, surtout au travail

Instructions à l'étudiant

Vous êtes médecin anesthésiste au CHU de Nice, vous recevez en consultation Mme Martin, une patiente de 62 ans pour une consultation pré anesthésique avant sa chirurgie ambulatoire d'un syndrome du canal carpien prévu sous anesthésie loco-régionale dans la semaine.

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Réaliser la consultation pré anesthésique et donner son score ASA
2. Expliquer à la patiente le déroulement de l'anesthésie loco-régionale

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tache 1	
Confirmer l'identité de la patiente	
Confirmer l'opération pour laquelle la patiente vient	
Demander les antécédents	
Demander les traitements en cours	
Demander les allergies	
Demander les toxiques	
Enoncer que la patiente est ASA 1	
Tache 2	
Expliquer que l'anesthésie locorégionale se fait par injection de produits à proximité des nerfs	
Expliquer qu'il n'y a pas besoin d'endormir la patiente et/ou expliquer qu'il n'y a pas besoin d'intuber la patiente	
Expliquer qu'il existe un risque de passer en anesthésie générale si échec	
Expliquer qu'il faut être à jeun	
Préciser que le jeun est de 6h pour la nourriture et 2h pour les boissons et 2h pour le tabac (*cocher si les 3 sont dits)*	
Explique qu'il existe un risque infectieux	
Expliquer que la patiente pourra rentrer chez elle le jour même	
Explique qu'il faudra se revoir avant l'opération pour une visite pré anesthésique	
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à structurer / mener l'entrevue	1 à 5
Aptitude à fournir des renseignements	
Communication non verbale	

UTILISER IMPERATIVEMENT DES VERBES d'ACTION ex : « Dit » « Énonce » « Palpe » « Écoute »
SEPARER CHAQUE ITEM (ex : « recherche une consommation de tabac » et « quantifie une consommation de tabac » sont deux items différents)

MAXIMUM 15 Items de compétence spécifiques et 5 items de compétences génériques
Choisir les plus pertinents/discriminants

Fournir des schémas pour les points cliniques à évaluer par l'examinateur (cadrans d'examen abdominal, foyers d'auscultation etc.)

Préciser quand l'examinateur doit intervenir pour donner un signe clinique positif

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

	Pondération (entre 1 et 5)
Tache 1	
Confirmer l'identité de la patiente	2
Confirmer l'opération pour laquelle la patiente vient	1
Demander les antécédents	1
Demander les traitements en cours	1
Demander les allergies	1
Demander les toxiques	1
Enoncer que la patiente est ASA 1	0,5
Tache 2	
Expliquer que l'anesthésie locorégionale se fait par injection de produits à proximité des nerfs	2
Expliquer qu'il n'y a pas besoin d'endormir la patiente et/ou expliquer qu'il n'y a pas besoin d'intuber la patiente	2
Expliquer qu'il existe un risque de passer en anesthésie générale si échec	1
Expliquer qu'il faut être à jeun	1
Préciser que le jeun est de 6h pour la nourriture et 2h pour les boissons et 2h pour le tabac (cocher si les 3 sont dits)	1
Explique qu'il existe un risque infectieux	1
Expliquer que la patiente pourra rentrer chez elle le jour même	0,5
Explique qu'il faudra se revoir avant l'opération pour une visite pré anesthésique	1
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à structurer / mener l'entrevue	Echelle de 1 à 5
Aptitude à fournir des renseignements	
Communication non verbale	

,

ASA Classification	Definition	Examples
ASA I	A normal healthy patient	Healthy, non-smoking, no or minimal alcohol use
ASA II	A patient with mild systemic disease	Mild diseases only without substantive functional limitations. Current smoker, social alcohol drinker, pregnancy, obesity (30<BMI<40), well-controlled DM/HTN, mild lung disease
ASA III	A patient with severe systemic disease	Substantive functional limitations; One or more moderate to severe diseases. Poorly controlled DM or HTN, COPD, morbid obesity (BMI ≥40), active hepatitis, alcohol dependence or abuse, implanted pacemaker, moderate reduction of ejection fraction, ESRD undergoing regularly scheduled dialysis, history (>3 months) of MI, CVA, TIA, or CAD/stents.
ASA IV	A patient with severe systemic disease that is a constant threat to life	Recent (<3 months) MI, CVA, TIA or CAD/stents, ongoing cardiac ischemia or severe valve dysfunction, severe reduction of ejection fraction, shock, sepsis, DIC, ARD or ESRD not undergoing regularly scheduled dialysis
ASA V	A moribund patient who is not expected to survive without the operation	Ruptured abdominal/thoracic aneurysm, massive trauma, intracranial bleed with mass effect, ischemic bowel in the face of significant cardiac pathology or multiple organ/system dysfunction
ASA VI	A declared brain-dead patient whose organs are being removed for donor purposes	